جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فوزيه عبدالمبعود عبدالوهاب محمد

المحافظة : المنوفيه **الحي / المدينة :** شبين الكوم **العنوان :** ظ

رقم البطاقة : 26407271701102 **رقم التليفون :** 01225290681 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 14-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 27-07-1964 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(--------------------------**)**

المقر بما فيه
التوقيع:(--------------------------**)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161]

قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/ محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/ ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

GRI-E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------- **ا.د/** ----------------------- **د/** ----------------------- **د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --
خطة العلاج : --
المستشفي : --- **قسم :** --
جهة العلاج : --- **نفقات :** --
ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: فوزيه عبدالمبعود عبدالوهاب محمد
National ID: 26407271701102

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

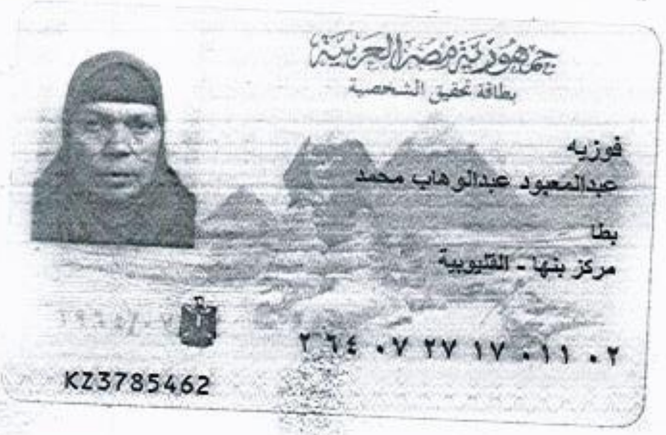
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	تاريخ وساعة الخروج : 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : **05-07-2026**	الوقت : **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



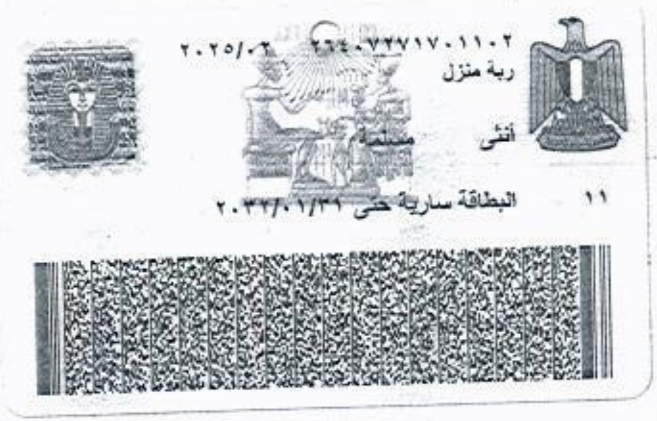
جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فوزيه
عبدالمعبود عبدالوهاب محمد

بطا
مركز بنها - القليوبية

٢٦٤٠٧٢٧١٧٠١١٠٢

KZ3785462



٢٦٤٠٧٢٧١٧٠١١٠٢ ٢٠٢٥/٠٣
ربة منزل
أنثى مسلمة
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/٣١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Fawzeya Abd Al Maaboud Abd Al Wahab Mohamed	Date : 16/08/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 58 Year(s)
Medical ID:	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

** HISTORY OF RIGHT BREAST CANCER:

Findings:

I Chest:-

- Right breast shows ill -- defined spiculating mass lesion noted in measuring about 25 x 36 mm. There is increased overlyning skin thickness.
- Pathologically enlarged level I axillary LNs ; the larges measuring about 19 x 15 mm.
- Right upper lung lobe posterior segment nodule is seen meaasuring about 6 mm otherwise no sizable masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- Enlarged liver with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Fawzeya Abd Al Maaboud Abd Al Wahab Mohamed	Date : 16/08/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 58 Year(s)
Medical ID:	

- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Small umbilical fat - containing hernia.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- D5 and D12 verterbral osseous hemangiomas are noted.

Opinion:

- ***Right breast malignant looking mass with right axillary lymphadenopathy.***
- ***Right upper lobe single nodule likely insignificant.***
- ***Mild fatty hepatomegaly with no focal lesions.***

Dr. Mohammed Mahjoub
Dr. Amr Farouk, M.D.

١١/٤

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

Patient Name: Fawzeya Abdel Maaboud Abdel Wahab **Date: 9/11/2022**

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

Report:

- No definite hot spot that account for active osseous lesions could be detected allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes at the spine.
- Both kidneys are seen.

Conclusion.

- ***No definite evidence of metastatic osseous deposits.***

Thanks for reference
Nuclear Medicine Unit

DR/Sherine Mahdy, MD

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

MDT form

[illegible] 29597773101151

Patient Age 53 Y

OIL [illegible]
APPENDECTOMY

Clinical data

Mets Workup:
CT CAP 8/22-->FREE,,BONE SCAN11/22-->FREE

ER: 8/8

PR: ?/8

Her 2 Neu: 1

Ki67: 35%

Sonomammography
6/22-->SUSPICIUOS RT BREAST LESION BIRADS V

PATIENT HISTORY
RT LOCALLY ADVANCED BC,,ENDED 12 WK TC + 2 CYCLES TIP
DENTAL ABCESS UNDER TTT,,,GOOD CLINICAL REPONSE
3/2023LN +VE (3/29)
PATHOLOGICAL PARTIAL RESPONSE
FREE DEEP MARGIN
STAGE:YPT2,YPN1

MDT OUTCOME & PLAN

for kadcyla - femara- PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number : m3558

اسم المريض : فوزيه عبدالمعبود عبدالله ذيب
السن : 58 Y
تاريخ اخذ العينة :
طالب التحليل : مستشفى بنها التعليمي
الجهة : مستشفى بنها التعليمي

النوع : Female
العنوان : بنها
تاريخ استلام العينة : 20/07/2022 09:43
تاريخ التقرير : 27/07/2022 13:04

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER &PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was **treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody**

sample recieved was **treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.**

sample recieved was **treated by :- CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbeit monoclonal primary antibody.**

Result :

ER: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
PR: weak nuclear staining of 10 % of tumour cells (core biopsy)
HER2/neu protein over expression : moderate continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells. (core biopsy)
Ki67 :positive nuclear staining of 10-15 % of tumour cells (core biopsy)

Referal Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)
PR: POSITIVE (SCORE 3/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : EQUIVOCAL (SCORE 2 +)
Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 10-15 %

Pathologist [illegible]

Lab Director [illegible]

10 El-sheikh Rehan Street, Abeideen, Cairo
Tel.(165)7948544 -7950096 Fax. (202)7948544
Mobile : 01144297292
Website http://www.healthlabs.net
email pathol:gychl@yahoo.com
[illegible]

This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ILA

يتم الاحتفاظ بالبلوك لمدة 30 يوم

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

[illegible]	[illegible]	Request No.	3008943
[illegible]	2640727170[illegible]	Request Date	01/02/2023
[illegible]	[illegible]/4/202[illegible]	Verification Date	05/03/2023
[illegible]	Female	Financial Category	[illegible]
Age	58 Y	Department	Out Patient
Referring Doc		Registered by	marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer post NACT .
Nature of the specimen:
Right MRM specimen , collected at 1/2/23

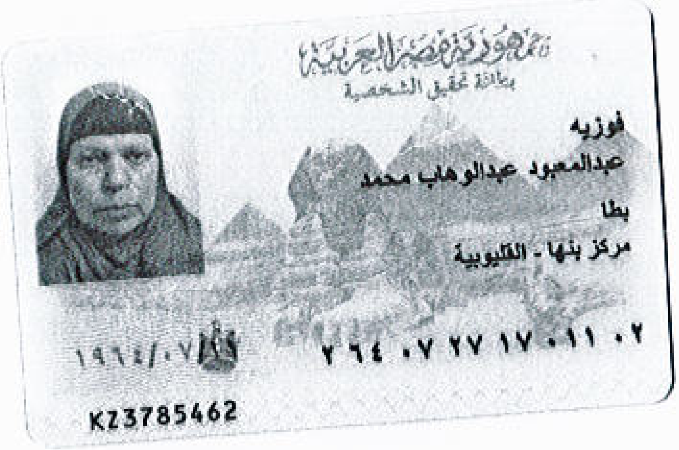
Gross Examination:
Right MRM measured 27x20x5 cm with covering skin ellipse measured 22x16 cm ;
[illegible] A greyish white firm tumor bed site
[illegible]
[illegible]: Nipple & areola were unremarkable grossly .
Distance from margins: 3 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 29 LNs up to 2x1 cm

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Residual tumor cellularity : 50%
- Ductal carcinoma in situ: Focal (20%)
- Lymph node involvement: (3/29) with focal capsular invasion
- Resection Margins: Free deep margin
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:
Right breast cancer post NACT , MRM specimen :
Invasive duct carcinoma grade II
- Free deep margin
- Lymph nodes:Positive (3/29) with focal capsular invasion
- Pathologic partial response
- Stage : ypT2 , ypN1
RCB [illegible].202 RCB class II

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

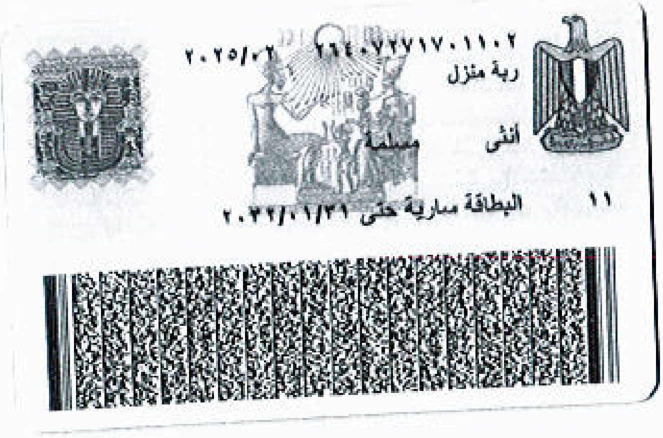
فوزيه
عبدالمعبود عبدالوهاب محمد
بطا
مركز بنها - القليوبية

١٩٦٤/٠٧/٢٧

٢٦٤ ٠٧ ٢٧ ١٧ ٠١١ ٠٢

KZ3785462

Dms
رشي



٢٠٢٥/٠٢ ٢٦٤٠٧٢٧١٧٠١١٠٢
ربة منزل
انثى مسلمة
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/٣١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]